

神経・筋疾患理学療法学 講義における指導方針

2027 年度前期 神経理学療法学 II 章担当

学問で終わらせない、臨床につながる理解を

- 授業内容が学生の中で持続する知識として定着すること
- 臨床場面で「何を評価し、どうリハビリすべきか」が実際に分かる状態を目指す
- 少なくともこの講義で扱った疾患については、実習で担当患者に対して評価・介入の方向性を自分で組み立てられるようにする

動画を活用した症状イメージの獲得

- 実際の動画などを積極的に活用し、疾患特有の動きや症状の具体的なイメージを持てるようにする

学ぶ意義の実感

- 疾患を学ぶ前に「なぜこれを学ぶ必要があるのか」を実感を持って伝える
- 例:有病率が高い疾患は、直接の入院原因でなくても併存疾患として遭遇する頻度が高いため、知っておく必要がある
- 「試験に出るから」ではなく「臨床上なぜ必要か」を先に理解してもらう

国家試験対策にもつながる内容

- 国家試験の過去問を授業内で活用する
- 「講義内容を理解していれば解ける」という達成感を通じて、自分の理解度・到達度を実感してもらう

授業内での理解度確認

- 各回の途中でセクションごとのまとめ・確認テストを実施し、気軽に理解度をチェックできるようにする
- この確認テストは国家試験過去問をそのまま活用することを検討中

振り返り用資料の整備

- 授業スライドとは別に、A4 縦 1 枚(疾患により両面・複数枚の場合あり)の振り返り資料を用意する
- 実習や国試対策で困ったときに、重要ポイントをすぐ思い出せるようにする
- ネット上で確認・共有できるようにする(患者の個人情報を含まない、公開可能な内容のみ)

口頭での説明力の育成(検討中)

- 頭で理解するだけでなく、学生自身が口頭で説明できるようになる工夫を取り入れたい
- 具体的な方法は今後検討

90分授業内での集中力・コミュニケーションへの配慮

- 45分を目安に必ず5分間の休憩を挟む
- 集中力の維持に加え、学生からの質問・疑問点に答える時間を意図的に確保する

疾患ごとの丸暗記ではなく、疾患間のつながりを重視

- 各疾患を個別に覚えるのではなく、疾患同士のつながりを意識した構成にする
- 共通する病態のメカニズム、共通して用いる評価項目などを横断的に扱う
- 例:脊髄小脳変性症の後に多系統萎縮症を続けて扱い、類似点と相違点を対比的に理解できるようにする

鑑別のための検査を通じた再学習

- 鑑別診断に必要な検査(特に脳画像などの読影の視点)を扱う中で、関連する解剖学的知識を学び直す機会とする
- 暗記ではなく、「なぜその検査が必要で、何を見ているのか」という基礎に立ち返る

臨床経験に基づいた、実感の伴う内容

- これまでの臨床経験を活かし、患者が実際に困っていたこと、関わりの中でうまくいったこと・いかなかったことなどの具体的な経験を盛り込む
- 教科書的な知識に臨床の実感を伴わせることで、記憶に残りやすい講義にする